



Crisis Hipertensiva ($> 180/110$)

¿Existe daño de órgano blanco?

- Deficit Focal
- Estado de conciencia alterado
- Cefalea intensa
- Disnea
- Dolor Torácico

NO

SI

Asintomático

Cefalea leve y/o
HTA $> 220/120$

Solicite TRASLADO UTI/UCI

Según sospecha solicite:
- TAC cerebro s/contraste
- ECG
- Rx Tórax
- Angiotac Tórax

HTA
Previo

Si

No

Reinicie
Fármacos
AntiHTA
previos

Disminuya
estímulos Externos
- Luz apagada
- Silencio

Analgesia
si dolor

BZD
Si Angustia

Si Edema Agudo de Pulmón
Inicie previo a traslado

NTG

+ Furosemida

Estudio básico
de causas 2arias
- Crea/BUN
- ELP
- Orina completa

Inicie AntiHTA
habituales según
exámenes

Descenso HTA en días

Inicie AntiHTA
de Vida media
Corta:
- Captopril

Titule luego
AntiHTA de
vida media
larga

Descenso de HTA
en 24-72 hrs

Si Edema Agudo de Pulmón
Inicie previo a traslado

NTG

+ Furosemida

Falla renal
Avanzada

Si

No

Dosis Altas EV
40 a 80 mg

Dosis bajas EV
(10 a 20 mg)

Descenso HTA en 10-20% en
1era hora, luego 5-15% en las
siguientes 23 hrs

